

18 - 10- La dépression chez l'enfant et l'adolescent - Pr. MANOUDI

Donc, on va parler de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Alors, vous vous rappelez de la dépression chez le sujet adulte. Donc, c'est quelque chose, même autour de vous, vous avez vu des adultes, soit dans la famille, soit dans votre entourage, qui ont fait des dépressions.

Mais je ne pense pas que vous êtes sensibilisés à la dépression chez l'enfant. À l'adolescent, à la rigueur, on peut dire oui, mais chez l'enfant. Est-ce qu'autour de vous, vous avez déjà entendu parler d'un enfant dépressif? Oui? Bien, d'un enfant, des parents qui ont consulté pour suspicion de dépression chez l'enfant.

En fait, c'est quelque chose, là, le diagnostic se fait de plus en plus. On voit de plus en plus de cas parce qu'on est de plus en plus sensibilisés à la dépression chez l'enfant et à la dépression chez le nourrisson aussi. On fait attention à ça.

Donc, comme vous le savez, bien sûr, la dépression, c'est la même, mais ce qu'il va y avoir comme différence, c'est au niveau de l'expression des symptômes. Un adulte va exprimer plus facilement les symptômes qu'un enfant, par exemple. Est-ce que vous avez des exemples? Des symptômes qui sont exprimés facilement chez l'adulte que chez l'enfant.

Est-ce que vous avez des exemples? La tristesse, excellent. Par exemple, un adulte, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis triste, je suis déprimé. Puisque nous, on les entretient, la population que vous allez voir, c'est des populations qui vont s'exprimer en arabe.

Vous allez poser, bien sûr, quand vous posez le diagnostic, quand vous faites les entretiens, c'est en arabe. Alors, un adulte déprimé, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse par rapport à avant.

C'est rare que les gens expriment la tristesse par ce mot-là. Ou carrément, il va y avoir des gens qui vont vous dire qu'ils sont déprimés. Ils vont vous dire qu'ils sont déprimés.

Ils vont vous dire qu'ils sont tristes. Ils vont vous dire qu'ils sont déprimés. C'est le terme le plus utilisé par la population.

Pour exprimer la tristesse, le problème chez nous, en arabe, en français, c'est facile. Vous allez poser la question, madame, ça va? Vous allez bien? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez déprimé? Directement la question. Ici, quand vous allez faire l'entretien, vous allez trouver des difficultés.

C'est ça les expressions qu'utilisent les gens. Un enfant ne va pas utiliser ces expressions. D'accord? Donc, il va utiliser, soit il peut l'exprimer d'une façon verbale, soit il va changer carrément de comportement, soit il va l'exprimer par des équivalents.

On va les voir par la suite. Donc, il est important d'identifier une dépression chez un enfant, chez

un adolescent, comme chez l'adulte. Donc, l'adulte, il est important de diagnostiquer une dépression.

Pourquoi il est important de diagnostiquer chez l'adulte? Parce que l'adulte, lui-même, il va souffrir. Donc, c'est important. Il peut souffrir.

C'est rare que les gens viennent après un mois de symptômes. Parce que le diagnostic, on le pose si les symptômes persistent après combien de jours? Quinze jours. Mais c'est rare que vous allez trouver des gens qui vont consulter au bout d'un mois, au bout de deux mois des fois, au bout de quelques mois.

Il viendra après six mois ou bien des années, après une année. Et tout ça, le patient, il souffre. Durant toute cette période avant de consulter, il souffre.

Donc, la même chose chez l'enfant, mais chez les enfants, qu'est-ce qu'il y a comme retentissement à la base? L'échec scolaire, surtout. Et la croissance aussi, ça peut retentir sur son développement affectif, sur son développement social et sur sa scolarité. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut le diagnostiquer avant.

Chez l'adulte, il y a le risque de passage à l'axe suicidaire. C'est pour ça qu'il faut le diagnostiquer avant. Mais chez l'enfant aussi.

Chez l'enfant, il y a les risques de suicide. Vous avez entendu parler des suicides à un âge très bas, à sept ans, huit ans, douze ans, surtout par rapport à certaines populations en particulier. Par exemple, au Japon, il y a des enfants qui se suicident.

Et bien sûr, l'adolescent, ça, c'est le risque aussi très élevé. C'est pour ça qu'il faut diagnostiquer. Donc, en tant que médecin généraliste, vous serez amené à voir des enfants et ils vont venir chez vous pour des équivalents dépressifs, des troubles somatiques, des plaintes somatiques, des troubles de sommeil, des anxiétés, de l'irritabilité, des changements de comportement, de l'inattention, des bagarres à l'école.

Donc, tout ça qu'on cherche, est-ce qu'il n'y a pas une dépression derrière? L'adolescent aussi, là, les parents qui vont les ramener, surtout pour les troubles de comportement ou bien pour les troubles de l'opposition. Et ça, des fois, on le classe dans le registre de c'est l'adolescence, c'est la crise d'adolescence, d'accord? Alors, repérer les facteurs de risque d'une population, d'une dépression chez cette population pour pouvoir les corriger ou bien pour pouvoir prévenir une dépression. Et bien sûr, connaître aussi le traitement d'une dépression.

Donc, si vous n'avez pas la main facile, parce que les enfants, il vaut mieux les adresser à un pédopsychiatre en cas de dépression. À la rigueur, en tant que médecin généraliste, vous êtes censé traiter une dépression. Vous ne voyez pas la dépression, s'il n'est pas compliqué, s'il n'y a pas d'indication à avoir une autre prise en charge spécialisée ou bien s'il n'y a pas une indication

à l'hospitalisation, vous ne l'adressez pas chez un psychiatre.

Vous devez connaître le traitement de la dépression chez l'adulte. Chez l'enfant, non. En tant que médecin généraliste, il vaut mieux l'adresser à un pédopsychiatre, sauf si vous êtes dans un patelin et il n'y a pas de pédopsychiatre.

Vous n'allez pas laisser l'enfant souffrir. Ou bien vous pouvez faire le suivi après. Une fois que le pédopsychiatre a vu l'enfant et l'a mis sous traitement, vous, vous pouvez faire le suivi après, mais toujours rester en contact avec le pédopsychiatre.

Et vous allez voir, je ne sais pas si vous avez affaire à un enfant, de faire un entretien, de lui poser des questions sur le plan psychologique. Vous allez être confronté à une difficulté que ce n'est pas comme chez l'adulte. Quand vous lui parlez, ce n'est pas comme vous parlez avec un petit enfant, votre frère, petit frère ou bien le petit enfant d'une amie.

Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas comme sa grande soeur, son grand frère et vous n'êtes pas comme sa maman ou son père. Donc c'est différent.

D'abord, elle est difficile. Alors bien sûr, la définition est la même. C'est un trouble de l'humeur, de l'humeur qui est caractérisé par un sentiment permanent de tristesse.

La tristesse, elle est permanente. Ce n'est pas comme les tristesses qui sont dues à des facteurs, des facteurs favorisants comme par exemple un deuil, une séparation, un échec, un problème, un conflit au travail. Et bien sûr, de l'irritabilité, la perte de plaisir à faire toutes les activités que le sujet aimait faire auparavant.

C'est ce qu'on appelle l'anédonie. Chez l'enfant aussi, on va trouver cette anédonie. Et on va voir aussi dans le DSM, il n'y a pas une dépression de l'enfant qui est catégorisée dans le DSM.

Il y a la dépression. Tout court, seulement au niveau de deux, je crois que deux symptômes seulement, on va les voir, où on va spécifier à la place de ce symptôme qu'est-ce qu'on va trouver chez l'enfant. Surtout l'humeur dépressive, comment ça va s'exprimer chez l'enfant.

Une pathologie psychiatrique qui est fréquente est sous-estimée. Pourquoi elle est sous-estimée ? Elle est fréquente, ça existe. Il ne faut pas la négliger.

Ça existe, il faut la chercher, il faut faire attention. Un enfant qui n'est pas compris et qui se sent qu'il n'est pas compris, c'est encore pire. Il peut vraiment avoir une évolution rapide péjorative de sa dépression qui peut aller directement vers le suicide ou bien la fugue, quitter la maison carrément.

Alors sous-estimée parce que soit on est dans le déni, on ne veut pas croire, ou bien on n'accepte pas, soit on ne cherche pas et on passe à côté. On va aller chercher un enfant par exemple qui se plaint qu'il y a des douleurs, on va aller vers le registre des douleurs, des

pathologies somatiques. Un enfant qui a des troubles de sommeil, on va aller vers le registre des troubles de sommeil, le cauchemar, les difficultés.

Est-ce qu'il a des problèmes à l'école par exemple ? Est-ce qu'il a peur de quelqu'un ? On ne va pas poser la question pour la dépression. Un enfant qui a des troubles alimentaires aussi, on va aller vers le registre. Est-ce qu'il a des problèmes gastriques ? Est-ce que c'est juste qu'il est gâté ? Est-ce qu'il mange toujours la même chose ? Est-ce qu'il cherche à compliquer les choses pour les parents ? Et on ne va pas aller vers le registre de la dépression.

L'expression clinique est polymorphe. Pourquoi elle est polymorphe ? Parce que l'enfant n'arrive pas à exprimer directement les symptômes. Il ne va pas vous dire « je suis triste », « je m'ennuie ». Des fois les enfants le disent.

Quand vous insistez, qu'est-ce que tu veux faire ? On fait ça, on fait ça. Non, non, je m'ennuie, viens, on va jouer, je n'ai pas envie. Mais des fois l'expression est difficile.

Il va l'exprimer surtout par des équivalents. Deuxième cause d'handicap dans le monde en 2020. Et pour l'adulte, ça va être la première cause en 2030.

Un problème majeur de santé publique, parce que ça retentit, comme vous l'avez dit, sur la scolarité. Et bien sûr, il peut y avoir aussi des complications péjoratives qui peuvent aller jusqu'au suicide. Ne pas oublier ça.

Chez l'enfant, c'est une affection qui est sévère, mais encore méconnue, comme on a dit. Soit on est dans le déni, soit on ne cherche pas. Soit on est dans une fausse orientation.

On cherche les autres symptômes. On travaille le développement de l'enfant, le développement social. Un enfant déprimé va s'isoler.

Il ne va pas pouvoir établir les relations sociales, ni les cognitions, et avoir un esprit social. Quand on établit des contacts sociaux, quand on apprend à l'enfant d'établir des contacts sociaux, on l'aide aussi à développer cet esprit social. C'est quoi l'esprit social ? C'est la capacité de comprendre les émotions des autres.

Quand il est en activité avec les autres enfants, ou bien quand il joue avec les autres enfants, si un enfant est triste, il est capable de se mettre à sa place. Ça se manifeste de façon apparente par de l'empathie. Donc ça, ça se développe par le contact social.

Mais si l'enfant est déprimé, il va s'isoler. S'il s'isole, bien sûr, pas de développement des compétences sociales, et bien sûr, ça va s'entendre aussi sur la scolarité. Il n'aura pas d'amis, et ça va aggraver sa dépression.

Ça entraîne un risque de suicide, et il faut le garder en tête. Un enfant, et même des enfants, il y a des enfants qui l'expriment. Je préfère mourir, alors là, je vais me suicider.

Il faut faire attention à ces mots-là. Ce ne sont pas des mots faciles, et ce ne sont pas des choses que les enfants sortent comme ça. Il faut leur parler.

Pourquoi tu dis ça ? Après, essayer d'explorer d'où ça vient. Des fois même, quand ils perdent dans un jeu, ils sont en train de jouer aux consoles, quand ils perdent, je vais me suicider. Et surtout chez les adolescents.

Les adolescents, il faut faire très attention. S'ils ne sont pas compris, s'ils ne sont pas écoutés, ça peut aggraver leur dépression. Nécessité de prise en charge précoce, surtout pour éviter aussi le suicide chez l'enfant et l'adolescent.

Et bien sûr, éviter la souffrance, et bien sûr, aider au développement scolaire, aider au développement social. Chez l'enfant, on commence en première intention, si ce n'est pas une dépression sévère. Parce que même chez l'enfant, on donne les antidépresseurs.

On commence par la psychothérapie. On va le voir. Mais si on est devant une dépression modérée à sévère, il faut passer par les antidépresseurs.

Ils ne sont pas contradictoires. À partir de l'âge de 8 ans, bien sûr. Mais il y en a des auteurs qui parlent de l'âge de 6 ans.

On peut commencer déjà les antidépresseurs. Comme je vous ai dit, ça relève du spécialiste. Donc quand vous allez arriver au point de donner les médicaments, là, il faut l'adresser au pédopsychiatre.

Vous, surtout, au premier stade, faire le diagnostic, orienter les parents. Et vous pouvez travailler sur la relation enfant-parent des fois, faire de la psychothérapie de soutien, la psychothérapie avec l'enfant, et en cas de besoin, adresser, comme je vous ai dit, si nécessité de prescription médicamenteuse. Donc l'enfant prépubère à 1 à 2 %, c'est quand même énorme.

Dans 100 personnes, 2 peuvent faire une dépression. L'adolescent, 5%. Dans 100 adolescents, 5 peuvent faire une dépression.

Prédominance féminine, comme toutes les dépressions. Prévalence plus élevée chez certaines populations, bien dans certains pays. Par exemple, des pays exigeants, par exemple le Japon.

Le Japon, l'enfant à 12 ans, il doit être performant. Il y a la compétition, la concurrence à l'école. Et si vous voyez des fois certains documentaires, les enfants, ils passent beaucoup de temps à étudier.

Alors les comorbidités sont très fréquentes, avec les troubles anxieux, avec les troubles de conduite alimentaire, avec les troubles de sommeil. Même si ces symptômes-là font partie des symptômes de la dépression. Alors il y a aussi, comme la dépression chez l'adulte, il y a aussi des facteurs génétiques.

Et il y a des études qui ont montré que la dépression maternelle, elle peut entraîner une dépression pendant la période périnatale, surtout chez l'enfant. C'est pour ça qu'il faut traiter la dépression maternelle. Chez une femme enceinte, toutes les femmes, elles ont peur de prendre des médicaments.

Mais il faut calculer le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Il vaut mieux des fois traiter une maman, comme ça elle va bien vivre sa grossesse, et elle va bien vivre par la suite la relation qu'elle a avec son nouveau-né, que de ne pas la traiter. Ça va retentir, sa souffrance retentit sur le fœtus et le bébé avant l'accouchement.

Et bien sûr, ça va retentir sur sa relation mère-nouveau-né, mère-nourrisson, après l'accouchement, ce qui peut aggraver la santé de l'enfant. Donc des fois, les mamans sont hésitantes, mais il faut les encourager à prendre le traitement pour traiter la dépression. Il y a des facteurs environnementaux.

Les événements de vie stressants, ce sont des facteurs de risque. La séparation précoce et surtout les séparations répétées, ça entraîne chez l'enfant les séparations répétées avec la maman, ou bien avec le substitut paternel. Ça peut être la grand-mère.

Ces séparations répétées sont plus graves que séparations une fois la maman, par exemple, laissant l'enfant à sa grand-mère, à sa mère, ou bien en cas de décès. Les séparations répétées entraînent des angoisses de séparation chez l'enfant, qui peuvent entraîner par la suite des dépressions chez l'enfant. Les maladies ou la perte d'un parent, les maltraitances pendant l'enfance, les conflits dans la famille.

Les conflits, des fois, il y a des enfants qui vont vivre dans les conflits durant des années. Depuis leur naissance, les parents sont en conflit jusqu'à 5 ans, 10 ans. Là, il faut bien, dans ces cas-là, vraiment, si on vous ramène un enfant qui est dans des conflits, dans la relation entre les parents, là, vous pouvez faire quelque chose par rapport à la psychééducation, ou bien à la thérapie de couple.

Au moins, ils peuvent se disputer entre eux, comme ils veulent, quand ils veulent, mais pas devant l'enfant. Au moins, vous essayez de régler ça. L'enfant ne doit pas vivre le conflit des parents.

Il y a même des parents qui le cherchent. Soit le père, il va le faire pour vexer la mère, par exemple, il va chercher à avoir des problèmes devant l'enfant, ou bien c'est le contraire. Donc là, au moins, si vous réglez ça, c'est déjà pas mal.

Les conflits des parents peuvent rester, mais pas devant l'enfant. Les enfants abandonnés, soit abandonnés dans la rue, soit un enfant abandonné par sa mère qui le laisse à son père, c'est surtout la relation mère-enfant qui va toucher beaucoup plus l'enfant, ou bien un enfant qui est abandonné par sa mère qui le laisse à sa grand-mère. Des fois, ils n'ont pas le choix, mais il faut

juste expliquer les choses à l'enfant.

Il faut que le substitut maternel remplace la mère sur le plan affectif. Le problème peut être réglé. Le harcèlement à l'école, les conflits avec les camarades à l'école, les échecs scolaires aussi, on va le voir dans le cours prochain, peuvent entraîner des dépressions.

Donc, soit le harcèlement à l'école, soit les instituteurs, les maîtresses, ou bien à l'école qui ne savent pas gérer le comportement d'un enfant, qui sont dans les critiques, qui sont dans les insultes devant les autres, qui sont dans l'humiliation devant les autres, et qui baissent l'estime de soi de l'enfant devant les autres. Ça aussi, ça joue. Il y a des enfants, surtout ça, le harcèlement à l'école et le comportement inadéquat des professeurs, des fois, qui ne vont pas être rapportés par l'enfant.

L'enfant peut vivre cette situation pendant des mois ou des années. Ça joue sur son humeur. La dépression des parents, surtout chez l'enfant de bas âge, ça entraîne les mauvaises qualités des interactions, surtout maman nourrissant.

La sévérité de l'éducation. Donc, des parents soit trop exigeants, trop sévères, des parents qui ne donnent que des punitions, pas de récompense, pas de renforcement positif, alors que ça aussi, c'est très important. Et ça aussi, vous pouvez travailler sur ça.

Donc, tous les facteurs favorisant, les facteurs de risque, vous pouvez les modifier par la psychoéducation. Les enfants, ce sont des enfants. On a beaucoup d'enfants dans notre population, dans notre milieu, qui ne reçoivent que des critiques.

C'est rare qu'un enfant, quand il fait quelque chose de bien, bravo, je t'encourage, je suis fier de toi. Et même des fois, si les mamans le disent, bravo, mais. Mais tu as fait ça, mais pourquoi tu as fait ça, mais pourquoi.

Non, il faut les moments des encouragements, les moments des motivations, les moments de renforcement positif. Renforcement positif, quand il fait quelque chose de bien, vous lui donnez un point positif, les bons points. Vous vous rappelez les bons points à l'école, ça, c'est un renforcement positif.

Donc, vous les laissez à part. Et si vous voulez critiquer, une chose, bien sûr, essayez de ne pas donner beaucoup de critiques. Mais à la fin de chaque critique, donnez quelque chose de positif.

Ou bien vous pouvez essayer de formuler la critique par une chose positive. Ça serait mieux que tu fasses comme ça au lieu de comme ça. Tu vois pas? Donc, au lieu de critiquer, pourquoi tu as fait comme ça? D'accord? Rien que pour ranger, par exemple, la chambre, ça serait mieux que tu fasses comme ça dans ta chambre au lieu de laisser les vêtements entassés sur le lit.

Si tu les mets bien, c'est bien, ce n'est pas mieux. Donc, essayez de donner la critique tout en étant d'accord avec l'enfant. Il ne va pas la recevoir comme critique.

Ça aussi, c'est très important parce que dans notre milieu, on a beaucoup de critiques. Et même à l'école, à l'école aussi. Et quand l'enfant reçoit des renforcements positifs, il est vraiment très content.

Et il peut aller quand on le racontait à ses parents. Ils font la différence. Et puis, s'il y a un autre problème à l'école, c'est les professeurs aussi qui font la différence entre les enfants, qui vont encourager un enfant beaucoup plus qu'un autre parce que l'autre, c'est vrai, elle fait des bêtises, ou bien l'autre, elle ne répond pas bien en classe, mais ce n'est pas une façon.

Donc ça, ça retentit négativement sur la santé mentale de l'enfant. Donc ça, au niveau de la sensibilisation, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Sur le plan manifestation clinique, la symptomatologie, comme je vous ai dit, elle est différente, mais surtout au niveau de l'expression des symptômes.

Alors, elle est variable selon l'âge de l'enfant. Un enfant à nourrisson ne va pas l'exprimer comme un petit enfant prépubère et ne va pas l'exprimer comme un enfant en début d'adolescence. On retrouve surtout des troubles associés qu'on va voir.

Alors, les circonstances d'apparition, c'est, on rapporte surtout avec des facteurs déclenchants, c'est soit à l'occasion d'un deuil, à l'occasion d'un divorce, ça peut être des causes anodines, par exemple, un enfant qui perd un animal de compagnie, ou bien un déménagement, un enfant qui change d'école, un enfant dont l'ami a déménagé, un voisin a déménagé, des choses vraiment qui peuvent être des fois anodines. Le début, bien sûr, elle est progressive, c'est pas comme des fois ça peut passer à bas bruit pendant des mois. Elle est très progressive parce que l'enfant ne s'exprime pas.

Et des fois, les parents ne vont pas constater la différence qu'après un certain temps. Chez l'enfant, ce qu'il y a surtout, ce qui marque surtout, c'est le changement par rapport à l'état antérieur, c'est surtout ça. Parce que l'adulte, elle est vraiment, l'activité de l'adulte, on connaît les activités de l'adulte, elles sont actives, des fois elle est fatiguée, des fois elle est active, des fois elle est un petit peu hyperactive.

Mais un enfant, qu'est-ce qu'on connaît d'un enfant ? Qu'est-ce qu'on connaît ? Ils sont hyperactifs. Un enfant, normalement, il bouge, il veut jouer, il pose des questions, il parle beaucoup, il veut tout le temps sortir, il est exigeant. Exigeant par rapport à la nourriture.

Je veux ça, non, je ne veux pas ça, non, je veux ça, je ne veux pas ça. Il va demander beaucoup de choses. Il est exigeant par rapport aux habits, des fois.

Non, je ne veux pas ça, je ne veux pas cette couleur. Il demande à sortir souvent. Donc, ils sont exigeants, ils sont hyperactifs et ils parlent beaucoup.

D'un jour, ça peut aller de façon progressive, c'est vrai, mais les mamans ne vont constater que lorsque, vraiment, ça se calme. Ils ne demandent plus à sortir, ils ne jouent plus, il n'est plus exigeant par rapport... C'est vrai, ça arrange les mamans. Ah, je suis tranquille.

Il n'est plus exigeant par rapport à ce que je lui donne à manger. Il faut se poser la question. Alors que ça, c'est un problème.

Qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'on mange le soir ? Ah non, je ne veux pas manger ce que j'ai déjà mangé à midi. Vous voyez, des fois, c'est des choses... Les habits aussi. Non, je ne veux pas mettre ça, j'ai déjà mis hier, je veux sortir, on est sortis le week-end, oui, mais je veux encore sortir.

Il ne se fatigue pas. Et puis, il pose des questions, il parle beaucoup. Et ça, ça change.

Donc, il va se manifester par un ralentissement psychomoteur plus ou moins marqué. Donc, le ralentissement, il est constaté. Surtout, bien sûr, s'il est marqué.

Mais vu que c'est un enfant qui est hyperactif, ce changement peut se constater. L'instabilité psychomotrice, des fois, l'agitation, l'irritabilité. Donc, quand il est agité, quand il est instable, ce n'est pas dans le sens de l'hyperactivité joyeuse.

Il est agité ou instable, mais il est irrité, il est nerveux. C'est dans l'irritation, dans la nervosité, et un petit peu de l'agressivité. Et la tristesse, on peut la constater par sa mimique.

Elle a une mimique triste. Et quand on dit quelque chose pour rigoler, quand il a normalement l'habitude de rigoler, il ne va plus rigoler, il ne réagit plus. Même avec ses copains, il ne réagit plus.

Je ne sais pas si vous voyez les enfants en train de regarder la télé. Des fois, elles s'éclatent de rire devant la télé. Et quand vous venez voir de quoi il s'agit, des fois, ce n'est rien du tout.

Pour vous, ce n'est rien du tout. Mais eux, ça les amuse. Alors, ces choses-là ne sont plus remarquées.

Un sentiment d'ennui. Et l'ennui, on va le voir quand on voit l'enfant un petit peu perdu. Il ne sait pas quoi faire.

Et quand il est irritable, quand il est instable, c'est parce qu'il s'ennuie. Il s'ennuie dans le sens où rien ne lui fait plaisir. Il ne veut plus sortir.

Il veut rester à la maison. En même temps, il s'ennuie. Et des fois, il va l'exprimer.

Je m'ennuie. Viens, on va sortir. Je n'ai pas envie.

Viens, on va jouer. Je n'ai pas envie. La flemme.

La flemme. Des mots qui vont commencer à répéter. Et bien sûr, quand il s'exprime, c'est un sentiment de souffrance morale.

Donc, un sentiment de dévalorisation. Je suis nul. Là, il va commencer à se culpabiliser.

Je ne sais pas. Chaque fois qu'on lui demande quelque chose. Je suis nul.

Donc, surtout quand il pense à quelque chose qui s'est passé à l'école. La maîtresse a donné un bon point à son copain. Et lui, non.

Je suis nul. Il y a des enfants qui sont contents de faire un effort par rapport à l'écriture. Par exemple, il écrit quelque chose ou bien une réponse, pour lui, il a fait un exploit.

Et il ne reçoit pas d'encouragement des professeurs. Ça, ça le rend vraiment triste. Pour les enfants, il faut faire très attention.

Je parle à l'école. Sentiment de culpabilité. Je suis méchant.

C'est ma faute. Quand il est critiqué, je suis méchant. Je suis quelqu'un de pas bien.

C'est comme ça qu'il l'exprime. Et ça, vous pouvez aussi le dire au maman. Quand il fait quelque chose de bien, il faut l'encourager.

Même s'il vous paraît quelque chose qui n'est pas très perturbant. Des fois, elle va essayer de débarrasser la table, ramener son assiette à la cuisine. C'est rien pour une maman.

Mais lui, pour lui, il a fait quelque chose. Et il attend de sa maman de lui dire, bravo, tu as fait ça. Les encouragements.

Perdre de l'estime de soi. Je ne suis bon à rien. Je ne m'aime pas.

On ne m'aime pas. Et lui aussi, il va dire, je ne m'aime pas. Donc ça, c'est plus grave.

Et bien sûr, tout ce qui est rapport avec un déficit cognitif, des troubles cognitifs, problèmes, difficultés à penser, à réfléchir. Quand on lui pose la question, et bien sûr, quand on va commencer à faire des exercices avec lui, on voit que c'est difficile, alors que les calculs, par exemple, il les faisait facilement. C'est quelqu'un qui a acquis les calculs de base, les additions, les soustractions.

Mais quand on va commencer à faire avec lui les exercices, les devoirs, on va trouver que c'est difficile. Donc, on doit se poser la question. Faire attention en classe, se concentrer en classe.

Et là, bien sûr, quand il ne se concentre pas en classe, il ne fait pas attention, la maîtresse vient de dire quelque chose. Il pose la question. Il ne répond pas.

Ça énerve la maîtresse. Il va crier sur lui. Il va commencer à le critiquer.

Et lui, il va vivre ça de façon très mal. Ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Rien que pour ça.

Il a été critiqué par la maîtresse. Il n'était pas bien. Il était triste, déprimé.

Il n'a pas bien suivi le cours. Et quand la maîtresse a posé la question qu'il vient d'expliquer, il n'a pas suivi parce qu'il avait du mal à se concentrer. Et il a été critiqué devant tout le monde par la maîtresse.

Là, il peut avoir des idées comme ça. Je préfère mourir que de retourner à l'école demain. Ça peut aller jusqu'à ce point.

Donc, des troubles de comportement chez l'enfant prépubère toujours, ce type d'irritation, d'excitation, l'excitation qui va être sous forme d'une défense maniaque. Des fois, on le voit. Quand vous êtes, par exemple, dans des anniversaires, vous voyez des enfants qui ne sont pas bien.

Un enfant qui a, si on peut dire entre guillemets, jaloux ou bien qui n'a pas eu le même anniversaire que son copain, il va être excité, mais d'une façon qui va déranger l'autre. Ça, on le constate des fois. Il va montrer qu'il est joyeux, qu'il est excité, qu'il est en train de s'amuser, mais d'une façon un petit peu irritée.

L'intolérance à la frustration, à la contrariété. « Viens, on va sortir. » « Non, je ne veux pas sortir, je n'ai pas envie.

» « Viens, si, on va sortir. Comme ça, tu vas changer, tu vas jouer. » Là, il va commencer à crier.

Les fugues des fois de la maison. Même un enfant, un petit enfant, il peut fuguer. Faites attention à la dépression.

10 ans, 11 ans, 12 ans. Et on a eu des enfants qui ont fugué de leur maison. L'agressivité des fois, ça peut se faire sur lui-même.

Il peut s'arracher les cheveux, s'arracher les ongles, essayer de s'autométuler aussi. Un enfant, on peut avoir des autométulations ou bien agresser les autres, ou bien agresser les animaux domestiques à la maison, ou bien casser les choses à la maison. Interruption des activités ludiques par manque d'intérêt.

Il n'a plus d'intérêt pour les jeux, pour l'activité du jeu. Là, les enfants, actuellement, on les voit très intéressés par les jeux électroniques. Donc, quand il va être déprimé, ça ne va plus l'intéresser.

Et ça, c'est trop bizarre. Un enfant qui aime jouer à toutes, je ne sais pas si vous connaissez, les jeux électroniques, Roblox, Fortnite, et tout ça, d'un jour au lendemain, ou bien petit à petit, il ne va plus montrer d'intérêt. Ça aussi, ça doit attirer l'attention.

Ralentissement avec inhibition intellectuelle. Ils sont actifs, donc ils vont devenir pas actifs. Inhibition intellectuelle, difficulté à se concentrer.

Et bien sûr, il va y avoir un repli, un isolement sur soi, et une inertie, une perte carrément d'énergie par la suite. Les troubles associés. On a dit que ces enfants-là, ils vont présenter beaucoup plus, ils vont manifester leur dépression avec beaucoup plus de troubles associés qui vont masquer le syndrome dépressif et qui vont constituer ses comptes à 70% des cas.

Troubles du sommeil. Donc, l'enfant, la maman va amener l'enfant juste pour des troubles du sommeil. C'est vrai, c'est un symptôme qui fait partie de la dépression, mais il faut poser les questions pour voir s'il y a une dépression ou pas, surtout les autres symptômes, pour voir est-ce qu'il fait partie de la dépression ou bien c'est un symptôme isolé.

Et il y a des médecins qui vont donner juste un traitement symptomatique. Ils ne dorment pas la nuit, ils ne vont même pas poser la question, ils ne vont même pas penser que c'est un enfant qui peut faire une dépression. Ils vont donner de la tharax, la tharax suro.

On le donne aux enfants, c'est un antihistaminique, pour aider l'enfant à s'endormir. Les troubles des conduites alimentaires. Alors là, il va y avoir de la psychoéducation, de l'éducation que pour l'alimentation.

On va voir les aliments que vous lui donnez, il faut diversifier l'alimentation, qu'est-ce que vous lui donnez, qu'est-ce que vous aimez. L'entretien ne va être qu'autour de ça. On ne va pas penser que c'est un enfant qui peut faire une dépression et que le trouble alimentaire c'est à cause de ça.

Les troubles sphactériens aussi. Quand on amène un enfant pour les troubles sphactériens, c'est un grand problème pour les mamans, surtout les enfants qui continuent à faire pipi. Après cinq ans, là, le médecin ne s'intéresse qu'à l'inurisie.

Donc, il va essayer de traiter que l'inurisie. On va voir, on va essayer de l'encourager. Faites-lui un agenda, un agenda du soleil, le jour où il ne fait pas le pipi, un agenda où il y a la pluie quand il fait pipi.

Ils vont cocher, ils ne vont discuter que de ça. Donc, il va oublier que ça peut faire partie de problèmes dépressifs. Alors, les plaintes somatiques.

Bien sûr, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas creuser pour voir l'organicité de ce problème. Quand il y a un trouble de sommeil, trouble de conduite alimentaire, trouble sphactérien, plainte

somatique, il faut d'abord faire un bilan pour voir s'il n'y a pas un problème organique derrière. Mais à côté de l'entretien pour chercher les causes organiques, à côté du bilan, parmi les causes organiques aussi, il y a la dépression.

Donc, il faut chercher aussi la dépression. Vous allez voir pour les plaintes somatiques, les douleurs abdominales. Une maman qui amène un enfant pour une douleur abdominale.

Bien sûr que le médecin va examiner. Le pédiatre doit examiner. Il doit faire un bilan.

On fait toujours un bilan pour un problème s'il n'y a pas d'amélioration après un premier traitement. Mais à la deuxième consultation, en général pour une douleur abdominale, on donne un traitement pour une semaine, 10 jours. Donc, si on est en retard pour diagnostiquer autre chose au bout de 10 jours, ce n'est pas grave.

À la deuxième consultation, il faut voir autre chose aussi. Il ne faut pas oublier de passer pour chercher les autres problèmes. Les troubles de l'apprentissage, le trouble de l'attention, le trouble de concentration, les difficultés de mémorisation.

Là, on est dans un registre psychique. Donc, je pense que les médecins vont être orientés pour chercher les problèmes psychiques. Ils vont chercher s'il n'y a pas une anxiété, s'il n'y a pas une dépression derrière ce problème-là, s'il n'y a pas un TDAH, s'il n'y a pas un autisme derrière ce problème-là.

Le problème s'oppose beaucoup plus quand il y a un problème somatique au premier plan. Alors, chez l'adolescent, on a rarement de masques dépressifs. L'adolescent, il y a des masques dépressifs, mais c'est rare parce que l'adolescent peut s'exprimer.

Mais quel est le masque dépressif le plus fréquent qu'on peut rencontrer chez l'adolescent? Quel est l'équivalent dépressif qu'on peut rencontrer chez l'adolescent? Comment il peut s'exprimer à un adolescent? L'opposition, oui. Les troubles de comportement et surtout l'opposition, transgresser la loi, chercher des problèmes. Mes parents ne me comprennent pas, ils ne font pas attention à moi.

Je n'attire pas leur attention, alors je vais attirer leur attention. Il va faire de la provocation. Et sinon, s'il peut s'exprimer, il va exprimer la tristesse.

S'il est plus proche de la maman, il va le dire à la maman. S'il est proche du papa, il va le dire à son papa, sinon à un frère. Sinon, il va le dire comme ça à un instituteur à l'école ou bien à quelqu'un de proche.

Mais c'est pour ça qu'il faut garder toujours avec l'adolescent la communication, toujours parler avec les adolescents pour qu'ils puissent verbaliser des choses qui les inquiètent. Sinon, c'est de l'irritabilité, des crises de colère, des pensées négatives, de dévalorisation. L'adolescent, surtout avec le changement morphologique, le changement physique, avec les relations sociales qu'il a,

avec les amis, avec les filles ou bien avec les garçons, là, ça peut entraîner des idées de dévalorisation, de culpabilité, d'impuissance, de désespoir, de déception par rapport aux parents, par exemple, s'il n'a pas de bonne note à l'école, il va avoir cette impression qu'il a déçu ses parents.

Et puis, il va y avoir petit à petit le retrait familial et social. Le retrait familial va se voir progressivement. L'enfant qui ne descend plus pour prendre le petit-déjeuner le matin, il s'habille rapidement et sort.

Au déjeuner, si jamais ils ont l'habitude de manger ensemble, il n'est plus là. Après le dîner, il peut manger dans sa chambre. Après, ça va être un enfant, un adolescent qu'on ne voit plus à la maison.

Un adolescent qui va rentrer et peut même rentrer de façon inaperçue. Les parents ne peuvent même pas se rendre compte. Ils sont fermés dans la chambre et ne sortent qu'au lendemain.

Ou bien, il peut rester plusieurs jours dans sa chambre. Sinon, c'est le cas contraire, c'est les conduites addictives. Et les conduites addictives, si un enfant, un adolescent est en dépression, il va rentrer dans des conduites addictives de façon inaperçue.

Les parents ne vont pas se rendre compte parce qu'il va aller progressivement, petit à petit. Eux, ils peuvent être préoccupés par pourquoi tu ne viens pas, pourquoi tu ne descends pas, pourquoi tu ne manges pas avec nous. Et l'enfant peut aller vers un autre chemin.

Les conduites addictives, ça commence par le cannabis, pour augmenter sa concentration, pour améliorer son humeur, par l'alcool. Donc, les enfants qui vont l'encourager à prendre de l'alcool, ça excite, ça désinhibe. Après, les autres prennent de la cocaïne, ça excite, ça va t'aider à dépasser ta dépression, ça va te donner de la joie.

C'est vrai, c'est le fait positif au début, de l'extasie aussi, pour faire la fête. Et c'est vrai, ça donne cet effet. Et puis, par la suite, il peut y avoir, avec ça, les conduites à risque, soit des conduites automobiles à risque, soit des addictions à risque, soit des fugues.

Et surtout, si l'enfant, l'adolescent, est déprimé, et il y a des problèmes à la maison, des conflits entre les parents, des parents qui ne l'écoutent pas, malgré ses problèmes, sa dépression, des parents qui continuent à le critiquer, qui le comparent aux autres adolescents, soit dans la famille, soit dans l'entourage, ça, bien sûr, il peut y avoir le risque de fugue ou bien le risque suicidaire. On a vu la dernière fois le risque suicidaire chez l'adolescent, les facteurs de risque. Chez les nourrissons aussi, il ne faut pas oublier que les nourrissons aussi, ils ont droit, et ils peuvent faire aussi une dépression.

Et ça a été constaté par des descriptions de Bob Lee et de Spitz, c'est des psychiatres, psychologues qui se sont intéressés à l'enfant, aux nourrissons, aux nouveau-nés aussi. Donc, le

nourrisson, bien sûr, il ne va pas verbaliser, il ne va pas s'exprimer verbalement, mais par le comportement. Ce sont des enfants qui vont être prostrés, qui ne bougent pas, qui sont abattus, en apparence indifférent.

Un enfant qui n'a pas vu, qui voit sa mère, même s'il vient de la voir, elle est avec lui, il cherche le contact de sa mère, il cherche le regard de sa mère, il cherche le sourire de sa mère, et il appelle la mère par le sourire. La communication des nourrissons, c'est par le sourire, c'est par le « hé », il attire l'attention. « Rack, capas », ça veut le constater.

« Hé », parce qu'il veut attirer l'attention de l'autre, il est dans la communication, il est dans la relation sociale avec les autres. Ou bien il peut communiquer avec les cris, il peut crier juste pour que quelqu'un vienne. Alors, pauvreté aux manifestations, des manifestations d'éveil ou du jeu, c'est ça, les manifestations d'éveil, c'est quand il appelle quelqu'un, quand il cherche à attirer l'attention de quelqu'un par un cri, par un mot, par une syllabe, par les babilles aussi.

Et les jeux, bien sûr, quand il commence à jouer, il n'a plus d'intérêt, il est dans l'indifférence. Les gestes d'auto-stimulation, il peut y avoir des gestes d'auto-stimulation comme des balancements, il essaie de se consoler. Des conduites auto-agressives aussi.

Il va essayer de mordre par l'arrachement des cheveux. On voit des enfants des fois qui sont un petit peu nerveux, irrités, qui sont en train d'arracher, des nourrissons, qui sont en train d'arracher leurs cheveux. Retard, bien sûr, des acquisitions psychomotrices et du langage.

Donc, il est prostré et il est abattu, il ne va pas chercher à développer sa motricité et son langage. Les symptômes aussi somatiques, ils sont fréquents. Il peut y avoir des troubles alimentaires.

Refuser de manger, refuser le biberon, jeter le biberon, du trouble du sommeil avec les cris, avec les pleurs, des infections dermatologiques. Ça peut aller jusqu'à des infections dermatologiques, des infections respiratoires. Ça peut aller même à des symptômes, vraiment, que vous dites, ça ne peut pas être déclenché par un enfant, même on a constaté des cas de fièvre.

Même chez l'enfant, des cas de fièvre d'origine psychique. On ne cherche pas l'étiologie de toutes les fièvres, on ne trouve rien. Ce sont des fièvres d'origine psychique.

Une fois que l'enfant est pris en charge sur le plan psychologique, tout rentre dans l'ordre. La même chose pour les troubles du sommeil, les troubles dermatologiques, les troubles alimentaires. Vous savez qu'il y a des infections dermatologiques qui sont dues au stress et qui évoluent en fonction de l'humeur de la personne.

Le psoriasis, par exemple, les eczémas, le zona, tout ça, c'est des signes, les structures, tous les structures, c'est des signes qui peuvent être en rapport avec un changement de l'humeur. Là, le diagnostic de SM5, on a le diagnostic de dépression chez l'adulte. Pour vous dire qu'il n'y a pas

un chapitre pour l'enfant.

Ce qu'il y a pour parler de l'enfant, c'est au niveau que deux, je crois, deux symptômes. Il y a ici, au niveau de l'humeur dépressive, là, elle est présente la plus grande partie de la journée, presque tous les jours, comme signalé par la personne. Je me sens triste, je sens un vide, je suis désespérée.

Ou bien l'adulte peut pleurer. Chez l'enfant et les adolescents, ça peut être remplacé par une humeur irritable. D'accord? Les autres symptômes sont presque les mêmes.

Il y a la perte de poids chez l'adulte. Chez l'enfant, elle est remplacée par quoi? C'est par la non-augmentation du poids attendu. Il peut y avoir une perte de poids, mais des fois, il peut être remplacé par la non-augmentation du poids attendu.

Normalement, l'enfant doit avoir une augmentation du poids. Donc, quand ça stagne, on tient compte que c'est une perte de poids. Donc, les symptômes et les côtés positifs.

Dans les autres, on n'a pas signalé quelque chose, mais ça veut dire que c'est des symptômes qui peuvent exister chez l'enfant. La pensée de mort récurrente, c'est le suicide. On a dit que ça existe chez l'enfant.

Les autres symptômes sont les mêmes. Pour faire le diagnostic, c'est difficile. Chez un enfant, vous allez vous aider par des échelles spécifiques à l'enfant.

Bien sûr, on a des questions adaptées à l'enfant. On ne va pas dire à l'enfant, est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes triste? Mais on va poser la question adaptée à l'enfant. Là, c'est des questionnaires en français et il y en a en anglais.

Malheureusement, il n'y a pas un questionnaire qui est traduit à ma connaissance. Le mini international est traduit de l'adulte. De l'enfant, je ne pense pas.

Il y a le mini international ici pour les enfants. Comme pour l'adulte, on a des formes cliniques aussi. Il y a les dépressions unipolaires.

L'enfant peut avoir des dépressions récurrentes qui se répètent. Il y a aussi les dépressions bipolaires. C'est surtout à l'approche de l'adolescence.

On peut avoir une dépression bipolaire. Quand la dépression est sévère, on peut avoir une dépression mélancolique aussi chez l'enfant. C'est les dépressions qui vont amener au suicide et bien sûr chez l'adolescent.

La dysthymie, c'est surtout chez l'adolescent. Les dépressions saisonnières aussi par rapport à l'adolescent. Trouble d'adaptation avec l'humeur dépressive aussi.

Adaptation soit au changement de l'école, soit au changement d'un milieu. Et il y a aussi les

dépressions psychotiques. Quand il va y avoir une apparition de certains symptômes psychotiques.

Surtout la méfiance, surtout avoir des peurs bizarres chez l'enfant. La peur par exemple, comme je l'ai dit la dernière fois, des trous de toilette. La peur par exemple du noir et avoir peur que des extraterrestres peuvent venir.

Les autres signes psychotiques, c'est beaucoup plus à l'approche de l'adolescence. Parce que les troubles bipolaires et l'adolescence, c'est 15-16 ans. Ça commence à 15 ans.

Mais il y a les prodromes, tout ce qui est signes négatifs, ça commence des fois dès 13 ans. Donc c'est les pédopsychiatres qui vont pouvoir détecter ces symptômes-là. Les comorbidités, comme je vous ai dit, on peut avoir une dépression associée à tous les troubles anxieux.

Un enfant peut avoir un toque. Il peut avoir une dépression qui complique son toque. Un enfant peut avoir de l'anxiété généralisée aussi.

Il peut avoir des attaques de panique. Il peut avoir un état de stress aigu suite à un événement stressant. On a vu dans les tremblements de terre des enfants qui ont fait des états de stress aigus.

Il peut avoir aussi des comorbidités avec des troubles de conduite. Un enfant peut avoir des troubles de conduite soit comportemental, soit des troubles de conduite alimentaire, soit des troubles de conduite addictive. Il peut avoir une association surtout avec le TDAH.

On a vu la dernière fois, ce sont des enfants qui sont étiquetés comme impolis, mal élevé, mal éduqué, qui dérangent tout le monde, personne ne veut jouer avec eux. Ils sont écartés. Cela diminue leur estime de soi.

Ils sont tout le temps critiqués. Parce que tout le temps, le TDAH, c'est glisser, concentre-toi. Il n'y a que ça.

En classe, il n'y a que ça. Et à la maison, il n'y a que ça. Il n'y a que ça.

Donc, ils peuvent déprimer. Comme complication, il peut avoir une dépression. Les TOCs, il est parmi les troubles anxieux qui apparaissent dès le bas âge, 7 ans.

On peut avoir un TOC dès 7 ans. Je me rappelle une patiente qui avait un TOC. Je l'ai vue à l'âge adulte.

Elle avait le TOC depuis qu'elle avait 10 ans. Mais le TOC est arrivé à son maximum à l'âge de 12 ans. Et qu'est-ce qu'elle avait comme TOC ? Vous avez fait le TOC ? Qu'est-ce qu'elle avait comme TOC ? Dans sa tête, elle avait deux listes de mots.

Une liste de mauvais mots et une liste de bons mots. Alors, à chaque fois qu'elle entend, par exemple, elle est devant la télé, elle entend un mot qui fait partie de la liste de mauvais mots. Elle doit rester devant la télé jusqu'à entendre le mot qui va neutraliser ce mauvais mot qui se trouve dans la liste de bons mots dans sa tête.

Elle peut rester devant la télé toute la journée. Des fois, elle s'écroule devant la télé parce que quand elle n'entend pas, vous savez que le fait d'entendre l'autre mot qui neutralise le mauvais mot, c'est la compulsion qui va diminuer son angoisse. Et quand elle était petite avec sa maman, par exemple, des fois, elle était avec sa maman à la plage, sa maman prononce le mot, par exemple, plage.

Ou bien quand elle est avec sa maman à la maison, sa maman prononce le mot plage. Et dans sa tête, elle, le mot plage est neutralisé par le mot sable. Elle doit poser des questions à sa maman jusqu'à ce que sa maman dise le mot sable.

Elle ne doit pas lui dire « maman, dis le mot sable », non. Et sa maman n'était pas au courant de ce que dit sa fille. Et la fille n'a pas osé dire à sa mère parce qu'elle ne savait pas que c'était un problème.

Et la fille commence à poser la question à la mère. « Maman, quand on va à la plage, qu'est-ce qu'on fait ? » « On nage ! » « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait à part nager ? » « On joue ! » « Oui, mais qu'est-ce qu'on... » Là, j'ai trouvé la facilité parce qu'elle va jouer. « On joue au sable ! » Supposons que la mère n'a pas sorti le mot.

« Oui, mais on joue au ballon ! » « À quoi ? » « On joue au coquillage ! » Il ne va pas sortir ce mot « sable ». Et elle, elle commence à poser la question, poser la question, jusqu'à énerver sa mère. Et sa mère ne savait pas de quoi il s'agit. Et quand elle était en classe, c'est la même chose.

Après, quand elle a grandi, moi, quand je la voyais en consultation, elle venait chez moi, c'était une patiente quand j'étais en stage en France. Elle venait chez moi et elle prenait le RER. Elle traversait des stations.

À chaque fois qu'elle traverse une station, quand elle a un mauvais mot dans sa tête, elle traverse la station. Et le mot n'est pas neutralisé par le bon mot, elle descend et prend le chemin inverse. Elle retourne, elle reprend le RER, le train, et elle fait des va-et-vient jusqu'à neutraliser le mot.

S'il ne neutralise pas le mot, elle peut passer toute la journée. C'est handicapant. Chez cette patiente, c'était un toquet très handicapant.

Au point qu'elle a fait des idées suicidaires, elle a fait des tentatives de suicide, elle a fait des dépressions. Vraiment, c'était handicapant. Il n'y a pas que ça.

Quand, par exemple, elle va aller faire les courses, quand elle fait les courses, quand on la voit, on dit que c'est une folle. Quand elle est en train de s'habiller, elle s'habille et s'il ne neutralise pas le mauvais mot qui vient à son esprit, il va enlever ses vêtements, il va s'habiller, il va enlever ses handicaps, il ne peut pas travailler. À la fin, elle a fait une tentative de suicide par arme blanche, par arme à feu.

Elle a pris un pistolet et s'est donné une balle au plein cœur. Elle a bien visé. Malheureusement pour elle, heureusement, elle n'est pas morte.

Elle a été hospitalisée en réanimation pendant un mois presque. Après, quand il est sorti, c'est là qu'on a commencé à parler. Moi, j'étais en stage en 2000.

C'est là qu'on a commencé à parler. Je vous dis ça entre parenthèses. C'est une histoire intéressante, je trouve.

On a commencé à parler du traitement chirurgical pour l'OTOC, parce qu'on a essayé tout avec elle. On a essayé tous les antidépresseurs, toutes les associations entre les antidépresseurs, les associations avec le neuroleptique, la sismothérapie, rien ne marchait. Et on a commencé à parler pendant cette période du traitement chirurgical.

Et là où j'étais, à la salle pétrière, on a commencé à faire les essais cliniques pour le traitement chirurgical. On recrutait des patientes pour leur faire la chirurgie. Mais dans la sélection de ces patientes, on sélectionnait les patientes qui n'avaient pas d'antécédents de suicide, de tentatives de suicide.

Et elle est venue pour être hospitalisée. Et au cours de son hospitalisation, c'est là où moi je l'ai vue pour la première fois. Et elle m'a raconté toute son histoire.

Et quand je rentrais chez elle en consultation dans la chambre, je finis mon discours, mon entretien. Et je ne dois pas aussi dire un mauvais mot. Si je dis un mauvais mot, elle va continuer à me poser des questions jusqu'à ce que je dise le bon mot.

Et elle, à la fin, elle a trouvé une astuce. Quand je rentre chez elle, je parle et puis elle ne m'interrompt pas. Et je sors, je lui dis, ça va, je n'ai rien dit.

Elle m'a dit, non, j'ai trouvé une astuce. Imaginez, c'est quelle astuce qu'elle a trouvée? Elle avait un dictionnaire avec elle. À chaque fois que je parle, si je dis un mauvais mot, elle touche le dictionnaire.

Et dans le dictionnaire, il y a tout. En gros, elle a ramené vraiment le plus grand. Elle touche le dictionnaire.

Et à chaque fois que je sors, je vois qu'elle n'a pas touché le dictionnaire, je lui dis, ah, je n'ai rien dit. Mais si je la vois toucher, je lui dis, ah, j'ai dit un mauvais mot de votre liste. Alors là, elle est

venue être hospitalisée dans l'espoir d'être sélectionnée pour la chirurgie.

Mais comme elle avait fait la tentative de suicide, on avait du mal. Elle peut commencer depuis un âge très bas, 7-8 ans, et peut faire souffrir les patients. Là, elle a fait vraiment souffrir cette patiente jusqu'à avoir des idées de dépression et des idées suicidaires.

Alors pour le diagnostic différentiel, comme on a dit, c'est des diagnostics qui peuvent être comorbides. Donc il faut éliminer tout ce qui est troubles du sommeil pur, troubles anxieux, troubles polaires. Et dans ces troubles aussi, on peut trouver des dépressions.

Alors, les affections organiques, une épilepsie, les épileptiques, on trouve de l'irritabilité, on trouve de la tristesse. On peut aussi trouver, surtout les enfants épileptiques, des fois, ils sont aussi stigmatisés par leurs camarades, parce qu'ils vont faire la crise, et parce qu'aussi vu la connotation, comme on appelle un épileptique, comme on appelle un épileptique en population générale, c'est le mot scientifique en arabe. Donc dire ça à un enfant, les enfants ont des problèmes d'école.

Donc ça, c'est des pathologies où on peut trouver l'hypothyroïde aussi. On peut se manifester par la dépression. Donc c'est des pathologies où on peut trouver de la dépression.

Donc si un enfant vient pour un symptôme dépressif, cherchez l'étudiant. La traitée. Des fois entraîne, bien sûr, l'hypothyroïde.

La dépression, elle est traitée. L'abus de substances. Aussi, on a dit la dernière fois que toutes les substances peuvent entraîner une dépression.

Il peut y avoir des changements de l'humeur par certains médicaments. Les plus connus, c'est les corticoïdes. Ils peuvent donner des dépressions, comme ils peuvent donner aussi des accès maniaques.

Et puis, il ne faut pas aussi, là je dois le mettre entre parenthèses, l'adolescence normale. Un adolescent normal, il peut être hyperactif, irritable, pas de façon continue. Mais dans la dépression, c'est continu.

Alors le traitement. Première intention, c'est les thérapies cognitives et comportementales. Thérapie familiale.

Vous, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire, c'est la psychoéducation des parents. La psychoéducation, surtout éviter les conflits devant les enfants.

Essayer d'aménager les enfants de vos problèmes. Thérapie de groupe. Des fois, surtout pour les adolescents.

Thérapie de soutien pour un enfant qui a des problèmes à l'école, des problèmes avec les

parents. Et puis, il y a des techniques de relaxation et des thérapies psychanalytiques. Le traitement.

En première intention, c'est les thérapies. En deuxième intention, en cas d'échec de la psychothérapie ou quand il y a une dépression sévère, on donne des antidépresseurs. Donc, l'antidépresseur qui est à l'AMM, qu'on peut donner chez l'enfant, est la fluoxétine à partir de 8 ans.

Bien sûr, il peut y avoir une répétition des épisodes dépressifs avec le risque, bien sûr, de chronicité, le risque de fugue, le risque de suicide, le risque d'échec scolaire, le risque d'addiction et le risque de complications hétéroagressives, des problèmes médicaux légaux. Donc, il faut la diagnostiquer pour la traiter de façon précoce pour éviter ces complications qui sont vraiment des complications sérieuses.